

Faringoamigdalitis viral y bacteriana (criterios de Centor y manejo antibiótico)

1. Introducción y relevancia clínica

La **faringoamigdalitis aguda (FAA)** es una de las causas más frecuentes de consulta médica en atención primaria, tanto en niños como en adultos jóvenes.

Corresponde a la **inflamación aguda de la mucosa faríngea y/o las amígdalas palatinas**, producida por virus o bacterias.

Relevancia clínica

- Causa frecuente de **consulta en APS y urgencias**.
 - La mayoría de los casos son **de origen viral (70–85%)**, y **autolimitados**.
 - Sin embargo, identificar las **etiologías bacterianas**, especialmente por **Streptococcus β -hemolítico del grupo A (SBHGA)**, es clave para prevenir **complicaciones supuradas y no supuradas** (fiebre reumática, glomerulonefritis).
 - El **EUNACOM** evalúa este tema recurrentemente por su relevancia en la práctica general y su vínculo con el uso racional de antibióticos.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Etiología

Tipo	Agente principal	Porcentaje aproximado
Viral (70–85%)	Adenovirus, rinovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza, VEB, CMV, enterovirus	Mayoría
Bacteriana (15–30%)	Streptococcus β -hemolítico del grupo A (Streptococcus pyogenes)	Más relevante clínicamente

Otras bacterias Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma pneumoniae

Casos aislados

2.2 Fisiopatología

- En la infección viral, los agentes invaden el epitelio faríngeo, provocando inflamación difusa, eritema y síntomas catarrales.
- En la infección bacteriana por **SBHGA**, la respuesta inflamatoria neutrofílica produce **exudado amigdalor, edema y fiebre alta**.
- La toxina estreptocócica (eritrogénica) puede generar **escarlatina** (exantema difuso).

2.3 Transmisión y epidemiología

- Transmisión: **aerotransportada o por contacto con secreciones**.
- Incidencia: mayor en **niños 5–15 años**, en meses fríos.
- Contagio favorecido por hacinamiento (escuelas, cuarteles).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Cuadro clínico comparativo

Característica	Viral	Bacteriana (SBHGA)
Inicio	Gradual	Brusco
Fiebre	Ausente o baja	Alta (>38,5 °C)

Odinofagia	Leve a moderada	Intensa, con disfagia
Tos	Frecuente	Ausente
Rinorrea / congestión nasal	Frecuente	Ausente
Exudado amigdalар	Raro	Frecuente
Adenopatías cervicales	Pequeñas, no dolorosas	Dolorosas, anteriores
Petequias en paladar	Infrecuentes	Características
Exantema escarlatiniforme	No	Sí (escarlatina)
Edad típica	<5 o >25 años	5–15 años

3.2 Examen físico

- Amígdalas hipertróficas, eritematosas, con o sin exudado purulento.
- En casos bacterianos: adenopatías laterocervicales dolorosas, halitosis.
- En casos virales: congestión nasal, conjuntivitis, úlceras orales o tos.
- En mononucleosis infecciosa (VEB): esplenomegalia y exudado blanquecino difuso.

3.3 Diagnóstico diferencial

Patología	Diferenciación clave
Mononucleosis infecciosa (VEB)	Exudado + linfocitos atípicos + esplenomegalia; test de Paul-Bunnell positivo.
Difteria	Pseudomembrana grisácea adherente, fiebre moderada.
Absceso periamigdalino	Desviación úvula, trismus, voz “hot-potato”.
Faringitis gonocócica	Sexualmente activa, exudado purulento sin fiebre.
Aftas o úlceras virales (HSV)	Lesiones ulceradas en mucosa oral.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Criterios clínicos de Centor modificados (McIsaac)

Criterio	Puntos
Fiebre >38 °C	1
Exudado o hipertrofia amigdalar	1
Adenopatías cervicales anteriores dolorosas	1
Ausencia de tos	1

Edad 3–14 años	+1
Edad 15–44 años	0
Edad ≥45 años	-1

Interpretación:

- 0–1 puntos → Riesgo bajo (<10%): no se requiere antibiótico.
- 2–3 puntos → Riesgo intermedio (15–30%): realizar test rápido o cultivo.
- 4–5 puntos → Riesgo alto (>50%): iniciar antibiótico empírico.

4.2 Test diagnóstico

Examen	Descripción	Disponibilidad
Test rápido de antígeno (Strep Test)	Detecta SBHGA en minutos, especificidad >95%, sensibilidad 70–90%.	Limitado en APS.
Cultivo faríngeo	Estándar de oro; resultado en 24–48h.	ORL o hospitalario.
Hemograma	Neutrofilia en bacteriana; linfocitosis en viral.	Apoyo diagnóstico.

4.3 Diagnóstico

Se establece por **clínica + Centor ≥3** o **test positivo para SBHGA**.

Debe descartarse mononucleosis (especialmente si hay exudado y linfadenopatías generalizadas).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Objetivos

- Aliviar síntomas.
- Erradicar el SBHGA para prevenir **fiebre reumática**.
- Evitar complicaciones supuradas.

5.2 Tratamiento sintomático (viral o general)

- **Paracetamol o ibuprofeno:** control del dolor y fiebre.
- **Hidratación abundante** y reposo relativo.
- **Gárgaras con agua tibia salada** o antisépticos suaves.
- Evitar irritantes (humo, alcohol, comidas ácidas).

5.3 Tratamiento antibiótico (bacteriana confirmada o probable)

A. Elección de primera línea

- **Penicilina benzatina IM:**
 - <27 kg: 600.000 UI IM dosis única.
 - ≥27 kg: 1.200.000 UI IM dosis única.
 - *Alta eficacia, asegura adherencia.*
- **Alternativa oral:**
 - **Amoxicilina 50 mg/kg/día (máx. 1 g c/12h)** por 10 días.

B. En alérgicos a penicilina

- Azitromicina 500 mg/día por 3 días, o
- Claritromicina 250 mg c/12h por 10 días, o
- Clindamicina 300 mg c/8h por 10 días.

C. En falla terapéutica o recurrencia

- Amoxicilina + ácido clavulánico 875/125 mg c/12h x 10 días.

5.4 No indicar antibióticos cuando:

- Presencia de tos, rinorrea o conjuntivitis (etiología viral).
- Centor ≤ 1 .
- Faringitis por virus Epstein-Barr (riesgo de rash con amoxicilina).

5.5 Medidas adicionales

- Aislamiento relativo (no compartir utensilios).
- Cambio de cepillo dental tras completar antibiótico.
- Reincorporación escolar: 24h después de iniciar antibiótico.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones supuradas

Complicación	Características
Absceso periamigdalino	Dolor intenso, trismus, desviación úvula.

**Absceso retrofaríngeo /
parafaríngeo**

En niños, fiebre alta, rigidez cervical,
disnea.

Otitis media / sinusitis secundaria

Dolor otológico o facial.

6.2 Complicaciones no supuradas (inmunológicas)

Complicación	Tiempo de aparición	Comentarios
Fiebre reumática aguda	2–4 semanas post infección	Evitable con antibiótico oportuno.
Glomerulonefritis postestreptocócica	1–3 semanas	No prevenible con antibiótico.
Púrpura de Schönlein-Henoch	Variable	Reacción inmunológica secundaria.

6.3 Pronóstico

- La mayoría de los casos virales son autolimitados (7–10 días).
- En FAA estreptocócica tratada, la resolución ocurre en 2–3 días.
- La fiebre reumática es excepcional si el antibiótico se inicia en ≤ 9 días.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Etiología viral predomina; no todos los casos requieren antibiótico.**

2. **Streptococcus β -hemolítico del grupo A** es el principal agente bacteriano.
 3. **Criterios de Centor ≥ 3** → alta probabilidad de infección estreptocócica.
 4. **Penicilina benzatina IM o amoxicilina 10 días** son tratamientos de elección.
 5. En **mononucleosis infecciosa**, **evitar amoxicilina** (rash en 80%).
 6. El **antibiótico previene fiebre reumática**, no la glomerulonefritis.
 7. En **recurrencias frecuentes**, evaluar portador faríngeo y contacto escolar.
-

Errores comunes

- Indicar antibióticos sin aplicar criterios de Centor.
 - Suspender el tratamiento antes de completar 10 días.
 - No evaluar complicaciones (absceso periamigdalino).
 - Administrar amoxicilina en mononucleosis.
 - Omitir derivación en casos con disfagia severa o trismus.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **faringoamigdalitis aguda** es predominantemente **viral**; el **Streptococcus pyogenes** es el único bacteriano relevante clínicamente.
2. El diagnóstico se basa en **criterios clínicos de Centor** y, si disponible, **test rápido o cultivo faríngeo**.
3. El tratamiento antibiótico **solo se justifica en casos bacterianos probables o confirmados**.
4. **Penicilina benzatina** (dosis única IM) o **amoxicilina 10 días** son las terapias de primera elección según **MINSAL Chile**.
5. **Evitar antibióticos** en presencia de síntomas catarrales (tos, rinorrea, conjuntivitis).

6. Las complicaciones incluyen **abscesos locales** y **fiebre reumática aguda**.
7. La adherencia terapéutica y la educación del paciente son claves para evitar recurrencias.